

GUÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA — Técnica ACCEPTS

Tolerancia al malestar · DBT (Dialectical Behavior Therapy) · Para uso del terapeuta en sesión

ACCEPTS es una habilidad de **tolerancia al malestar** de la DBT. Su función es ayudar al paciente a atravesar momentos de alta intensidad emocional sin llevar a cabo conductas dañinas, distrayendo la atención del malestar el tiempo suficiente para que la intensidad emocional disminuya por sí sola. No resuelve el problema de fondo ni elimina la emoción — **actúa en el intervalo entre el impulso y la conducta**, ampliando ese espacio para que el pico emocional baje.

Nota clínica: usar ACCEPTS no es evitar el problema, sino sobrevivir al momento de mayor intensidad para poder abordarlo después con más recursos.

LAS SIETE ESTRATEGIAS

A ACTIVITIES Actividades

Realizar cualquier actividad que requiera atención suficiente para competir con el pensamiento rumiativo o el impulso. La eficacia depende del grado de absorción que produce la actividad en ese paciente concreto. **En sesión se construye con el paciente una lista personalizada** — videojuegos, dibujo, música, lectura, series, ejercicio, cocinar — no una lista genérica.

Guión para el terapeuta:

«Cuando el malestar sea muy grande, no tienes que resolverlo ahora mismo. Solo tienes que hacer algo que ocupe tu cabeza el tiempo suficiente para que la ola de emoción baje. La emoción intensa siempre baja — nunca se queda al mismo nivel para siempre.»

C CONTRIBUTING Contribuir

Realizar algo útil para otra persona o para algo más grande que uno mismo: ayudar a alguien, cuidar un animal, hacer algo por el entorno. Activa sistemas de afiliación y recompensa que contrarrestan el aislamiento y la desesperanza, desplazando el foco desde el dolor propio hacia el exterior. **No tiene que ser algo grande:** mandar un mensaje, dar de comer a un animal o hacer una tarea útil para el entorno inmediato son suficientes.

Guión para el terapeuta:

«Cuando estamos muy dentro de nuestro propio dolor, salir un momento hacia fuera — aunque sea hacer algo pequeño por alguien — puede cambiar algo en cómo nos sentimos. No porque el problema desaparezca, sino porque activa una parte diferente de nosotros.»

C COMPARISONS Comparaciones

Ampliar temporalmente la perspectiva comparando la situación actual con momentos propios anteriores en los que el malestar era igual o mayor y se superó. El objetivo no es minimizar el dolor sino generar distancia cognitiva temporal. **Debe introducirse con cuidado** para evitar que se convierta en invalidación del dolor presente: el foco debe orientarse siempre hacia la propia historia de supervivencia del paciente.

Guión para el terapeuta:

«No estamos diciendo que tu dolor no sea real o que no importe. Estamos buscando un momento de perspectiva. ¿Ha habido momentos anteriores en los que sentiste algo parecido y lo atravesaste? ¿Qué te ayudó entonces?»

E EMOTIONS

Emociones opuestas

Generar intencionalmente una emoción diferente a la que está causando el malestar — no para suprimirla sino para crear un contrapeso temporal que reduzca su intensidad. Ver algo que provoque risa, escuchar música que genere otro estado, ver imágenes que activen ternura o admiración. **En sesión se identifica con el paciente qué contenido produce emociones distintas**, construyendo una lista de recursos personalizados de acceso rápido.

Guión para el terapeuta:

«No te estamos pidiendo que finjas sentirte bien. Te estamos pidiendo que expongas tu sistema emocional a algo diferente durante un rato, para que la emoción que te desborda tenga un poco menos de espacio. Es como abrir una ventana cuando hay demasiado humo.»

P PUSH AWAY

Apartar

Apartar temporalmente el pensamiento o la situación dolorosa de forma deliberada, con la intención explícita de volver a ello cuando haya más recursos disponibles. Se puede visualizar como poner el problema en una caja, en una estantería o detrás de una puerta. **Es fundamental dejar claro que apartar no es negar**: es una decisión activa y temporal de no procesar ese material ahora mismo.

Guión para el terapeuta:

«No estamos diciendo que el problema no existe. Estamos diciendo que ahora mismo no es el momento de mirarlo, porque tienes demasiada activación para hacerlo de forma segura. Lo guardamos por ahora y lo retomamos cuando estés en mejor disposición.»

T THOUGHTS

Pensamientos

Sustituir temporalmente los pensamientos rumiativos por otros que ocupen la mente de forma neutral, **sin combatir los pensamientos dolorosos directamente**. Contar hacia atrás desde cien de tres en tres, recitar letras de canciones conocidas, describir en detalle un lugar familiar, resolver mentalmente un problema sencillo. No se trata de pensamientos positivos forzados sino de competición atencional.

Guión para el terapeuta:

«No te pido que pienses en positivo ni que ignores lo que sientes. Te pido que des a tu mente otra tarea durante un rato. Algo que la mantenga ocupada — contar hacia atrás, recitar algo que te sepas de memoria, describir mentalmente un lugar que conozcas bien.»

S SENSATIONS

Sensaciones

Generar sensaciones físicas intensas pero inocuas que compitan con el malestar emocional: sostener hielo, masticar algo con sabor fuerte, oler algo intenso, ducharse con agua fría, escuchar música a volumen alto. **Especialmente relevante en pacientes con conductas autolesivas**: actúa sobre el mismo sistema de regulación que la autolesión — la necesidad de sensación física intensa — sin producir daño.

Guión para el terapeuta:

«A veces lo que el cuerpo busca es una sensación física fuerte que interrumpa el malestar emocional. Podemos darle eso de formas que no dañen. El hielo, el sabor intenso, la música fuerte producen una sensación real e intensa que cumple esa función sin dejar consecuencias.»